

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Jum'at / 27 Februari 2026
 PUKUL : 12.30 – 15.00 WIB
 AGENDA RAPAT : Rapat Bulanan Unit Pelayanan

PEMIMPIN RAPAT : Puput Sekar
 NOTULIS : Puput Sekar
 TEMPAT : Hall Sakura Lantai 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	ERM di IKO	1) form persetujuan dari poli untuk px loadingan yg dimintakan hanya untuk persetujuan tindakannya, untuk anestesinya tidak 2) ERM perioperatif belum bisa digunakan 3) ERM pengkajian pra anestesi: perawat ga punya hak akses untuk edit nama tim (apa bisa dibuat otomatis = laporan operasi) 4) penandaan di ERM belum seragam ada yg menggunakan garis ada yg menggunakan blok kuning	1) ERM dimintakan di poli juga dan dimintakan di irna sebelum px operasi agar saat tindakan di OK semua persetujuan sudah lengkap	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer
2)	Masalah di maternitas	1) tidak ada etiket infus dari IGD, IKO sampai di maternitas infus juga tidak ada etiket dikarenakan merasa tidak memasang infus 2) DRM di unit habis tidak order sehingga saat dibutuhkan cyto harus meminta ke unit lain(form transfusi) 3) copas SOAP dari template untuk di erm tidak di edit kembali sehingga salah TTV, tolak ukur 4) pemakaian oksitosin dan merhilergometrin di showcase tidak di tulis di ceklis	Untuk serah terima lebih diperhatikan termasuk ketersediaan etiket, supervisi PJ unit harus jalan	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer



3)	DPO	1) obat paket SC yang sudah di resepsi dan di retur tetap muncul di DPO sehingga tampilan nya banyak. 2) Advice DPJP untuk dosis tapering up tidak ada, pagi ini sudah ditambahkan master 3) Untuk obat yang Interaksi harusnya muncul di resep.dan saran ada warning nya. Atau kasih noted dan disosialisasikan ke perawat yang paling sering kasusnya interaksi obat di PHM apa saja	Koordinasi dengan farmasi dan programmer terkait ERM	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer
4)	Masalah di ICU	1) Pasien intubasi bulan februari meningkat dari yang sebelumnya 7-8 pasien/bulan, bulan ini sudah 12 pasien, unit kesulitan dalam pemakaian suction yang bergantian karena kabel power sering error. 2) Kesulitan DPJP anastesi saat intubasi pada pasien yang mempunyai penyulit (pasien leher pendek dan mengalami bleeding). 3) Lembar keluar masuk icu sudah ada di menu simrs tapi masih error, jadi kita masih pakai manual karena sering dapat PR dari RM 4) Pasien dari IGD a/n Tn. Suhar dpjp dr. fachriy konsul dr heri pasien pro evd dengan DM. Adv dr.denny acc op target GDS <200 pre op. pasien dipindahkan ke ICU tapi dr.heri tidak diinfokan bahwa pasien rencana op. karena pasien dipindahkan ke icu malam kita lapor kondisi dini hari dan dr heri baru bisa membalas pagi.	1) Pengajuan suction sudah proses pengajuan barang 2) dr.heru SpAn icu harus punya alat magill forceps, sudah proses pengajuan barang 3) lapor programmer 4) Tertibkan kembali untuk handover yang baik dan harus teliti terutama jika pasien operasi dengan konsul regulasi GDA atau noted yang lain	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer
5)	Kekurangan sursim PAP	PAP 2.1 EP 2 1) Pedoman pelayanan geriatri 2) Pedoman kerja tim geriatri (sudah ada)	Segera dikerjakan untuk pemenuhan elemen EP	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer



		3) Program pelayanan geriatri rumah sakit 4) Program kerja tim geriatri (sudah ada) PAP 2.3 EP 1 SK kemampuan pelayanan RSPH (jiwa) PAP 2.3 Ep 3 Hasil Kinerja poli jiwa 1) Supervisi poli jiwa 2) Umandok rapat bulanan pelayanan jiwa PAP 2.4 EP 4 Pelatihan dan Diklat skrining, pengkajian, dan tata laksana pasien risiko bunuh diri Sertifikat diklat PAP 2.4 EP 6 Pelaporan dan Monev bunuh diri		
6)	Kekurangan sursim Tim PONEK	1) EP pakai starkes terbaru---> a.b.c bukan angka 1.2.3 2) EP 1.1 baca buku pedoman penyelenggara ponek tahun 2012 3) EP 1.2 SK tim ponek belum update no kebijakan 4) EP 1.3 revisi program kerja (Rapat tim,pelayanan antenatal) acuan yang dipakai untuk melakukan kegiatan ponek (pedoman ponek) 5) membuat program ponek --> 8 point 6) EP 1.4 disiapkan data 1 tahun Juni 2025 - Juni 2026	Segera dikerjakan untuk pemenuhan elemen EP	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer



		7) EP 1.5 evaluasi dan RTL di sesuaikan dg bahasan 8) PN 1.1.1 berbagi pengalaman--> di jelaskan di prima ibu senmil bisa melahirkan normal dg lancar. 9) PN 1.1.2 pembinaan jejaring berjala 1 tahun 3 kali		
7)	Karu wajib menyapa pasien rawat inap	Tugas Karu IRNA : 1) Menyapa pasien 2) Yang ditanyakan adalah keluhan, makannya habis atau tidak, dari igd ke rawat inap lama atau tidak, keluhan sarpras RS ada yang rusak atau ada kendala 3) Terkait dpjp rencana visite, silahkan diinformasikan estimasi jam nya 4) Khusus untuk unit perinatology dan unit ICU/PICU/NICU karena keluarganya tidak selalu stanby, jadi silahkan ditanya keluhan dan kendala nya saat KIE pasien. 5) menyapa pasien diperuntukkan untuk pasien yang sadar dan tdk penurunan kondisi. 6) Jadi jika di ICU, pasiennya perburukan, tidak perlu di KIE	Segera dijalankan oleh karu pelayanan di rawat inap	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer
8)	Diskusi saran dan masukan saat rapat	1) Saran dr ardhi, ditambahkan fitur melihat resep sebelumnya di CPPT 2) Infus didata per unit, brp yg gagal, dicatat untuk mengetahui apakah gagal infus itu dari segi kompetensi atau memang dari klinis pasien yang tidak mudah untuk diinfus 3) Kebutuhan IV cannul di ruangan diperlukan untuk pasien yang urgent, flebitis atau	Koordinasi dengan farmasi terkait BMHP Koordinasi dengan programmer terkait ERM	1. Kabid Yanmed 2. Karu 3. Programmer



		penurunan kesadaran dengan mempertimbangkan kondisi jaga perawat 1 atau 2 orang saja per unit 4) Saran dari dr. Oka, SpOT untuk kondisi umum dan TTV pasien yang operasi, link dari IGD, sehingga DPJP tidak cenderung “mengarang” agar data lebih valid jika datanya dari igd sesuai pemeriksaan, hal ini berlaku untuk operasi elektif maupun cito		
--	--	--	--	--

Pemimpin Rapat
Kepala Bidang Pelayanan Medis



(Puput Sekar, Amd.Keb, SE)

Malang, 28 Februari 2026
Notulis



(Puput Sekar, Amd.Keb, SE)

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DOKUMENTASI

